

EXAMEN NEUROLOGIQUE

MÉNINGISME(SYNDROME MÉNINGÉ)

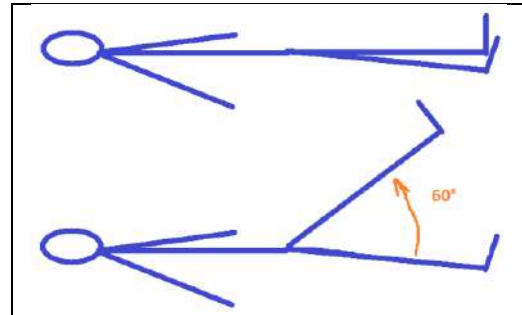
SIGNES

Anamnèse:

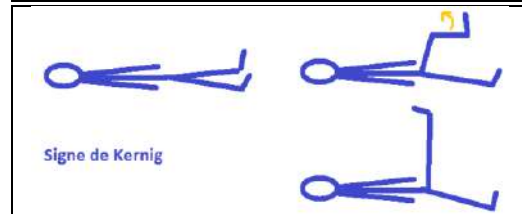
- Céphalées
- Nausées, vomissements
- +/- fièvre

Status:

- Signes méningés:
 - Raideur de nuque:
 - Le patient est placé en décubitus dorsal. L'examineur se place en arrière du patient.
 - Il fléchit la tête du patient.
 - Si le patient ressent une douleur lors de la flexion, il souffre d'une raideur de la nuque.
 - Signe de Kernig
 - Signe de Brudzinski:
 - Le patient est placé en décubitus dorsal. Le drap du lit est enlevé pour bien identifier les membres inférieurs.
 - L'examineur saisit la tête du patient avec ses deux mains et la soulève.
 - Le signe est positif si le patient soulève (ou plie légèrement) ses membres inférieurs.
- Fièvre
- Position fœtale : Dans le cas d'un méningisme, la douleur est augmentée en extension (car elle provoque l'étirement des méninges) et soulagée en flexion, c'est-à-dire en position fœtale.



Signe de Lasègue: signe d'irritation des racines lombaires
La flexion de 60 degrés du membre inférieur du patient en décubitus dorsal provoque une douleur avant d'atteindre les 60 degrés si le patient a une lésion entre L5-S1 (signe d'irritation).



Signe de Kernig:
L'examineur demande au patient de se placer en décubitus dorsal. Le patient fléchit sa cuisse à 90°. Le patient fléchit sa jambe à 90°. Le patient étend sa jambe. Si l'extension provoque une douleur (dans le dos), le patient souffre d'une irritation méningée.

CONSÉQUENCES

Le méningisme est une urgence vitale dans le cas de deux situations:

- Méningite: maladie très bruyante surtout si elle est provoquée par un méningocoque (si autres germes, maladie moins bruyante).
- Hémorragie: méningisme provoqué par l'inflammation des vaisseaux sous-arachnoïdiens. Il y a peu de fièvre.

La raideur de la nuque peut être présente sans méningisme. Le torticolis provoque une contracture musculaire palpable. Dans le cas d'une maladie de Parkinson, la raideur est aussi présente dans les autres parties du corps.

ETAT DE CONSCIENCE (VIGILANCE)

PHYSIOLOGIE

L'état de conscience dépend de la formation réticulaire activatrice ascendante.

La formation réticulaire activatrice ascendante est un réseau de fibres prenant leur origine au niveau de la formation réticulaire dans le tronc cérébral et se projette au niveau du cortex via le mésencéphale et certains noyaux thalamiques. Elle assure l'éveil cortical et la capacité de réaction modulée aux stimuli environnants.

Elle est modulée par de multiples afférences en particulier sensibles (auditives) et sensorielles (le toucher).

Dans le cas d'une perte de la vigilance, il faut trouver la cause. Un AVC thalamique bilatérale peut être responsable. Un AVC cortical n'est pas suffisant. Il faut que tout le cortex soit atteint. Une affection générale comme une encéphalite, une hypotension, un problème métabolique ou électrolytique peuvent être responsables.

Le noyau réticulaire thalamique (membrane fine qui enveloppe le thalamus) inhibe tous les (autres) noyaux thalamiques et par conséquent, le cortex. La formation réticulaire activatrice ascendante a deux fonctions. Elle stimule les noyaux thalamiques et inhibe le noyau réticulaire.

DÉFINITION

Éveil: état physiologique caractérisé par une capacité intacte d'interactions sensorielles, motrices et intellectuelles avec le monde extérieur.

Sommeil: état physiologique d'apparition périodique caractérisé par un repos comportemental et une perte plus ou moins complète des possibilités de relation avec le monde extérieur.

Somnolence: état intermédiaire entre la veille et le sommeil caractérisé par une tendance irrésistible à l'assoupissement si le sujet n'est pas stimulé.

Coma: altération de l'état de conscience caractérisée par une perte de l'intelligence, de la sensibilité et de la faculté de se mouvoir. Le sujet ne peut être éveillé par la stimulation verbale ou même douloureuse.

Entre la somnolence et le coma on définit encore l'obnubilation et la stupeur dont les définitions sont moins précises.

GLASGOW COMA SCALE

Ouverture des yeux	Réponse verbale	Meilleure réponse motrice*
Spontanée (4) A la demande (3) A la douleur (2) Aucune (1)	Orientée (5) Confuse (4) Inappropriée (3) Incompréhensible (2) Aucune (1)	Obéit à la demande verbale (6) Orientée à la douleur (5) Evitement non adapté (4) Décortication (flexion à la douleur) (3) Décérébration (extension à la douleur) (2) Aucune (1)

Le Glasgow est toujours au minimum à 3. Un correspond à une échelle entre 5 et 6.

FORCE MUSCULAIRE

Un grand merci à Olivia Corda pour sa participation.

THÉORIE

Rappel cotation force musculaire ; système MRC 0 - 5 (contre gravité avec maintien = 3), normal = 5, si < 5 = parésie ou faiblesse musculaire (MRC=Medical Research Council ou conseil scientifique britannique ayant reconnu après la 1ère Guerre mondiale l'utilité d'une cotation internationale) .

Performance réalisée	Kendall	MRC
Maintien de la position d'examen contre pesanteur et opposition maximale.	100	5
Idem mais maintien contre une opposition modérée.	80	4
Idem mais maintien contre une légère opposition.	60	3 +
Maintien de la position d'examen contre pesanteur ou possibilité d'amener le segment dans la position d'examen et de l'y maintenir contre pesanteur.	50	3
Abandon progressif de la position d'examen contre pesanteur, ou une légère assistance est nécessaire pour compléter le mouvement ou bien le mouvement est complet dans toute son amplitude en atténuant l'action de la pesanteur.	40	3 -
Possibilité de mobilisation du segment dans une amplitude partielle pesanteur atténuée.	20	2
Pour les muscles apparents ou accessibles au palper une faible contraction peut être perçue dans le muscle, ou bien le tendon peut faire saillie lors de la contraction musculaire, mais il n'y a aucun mouvement décelable.	5	1
Aucune contraction perçue.	0	0

La précision de l'examen est fonction des hypothèses de travail

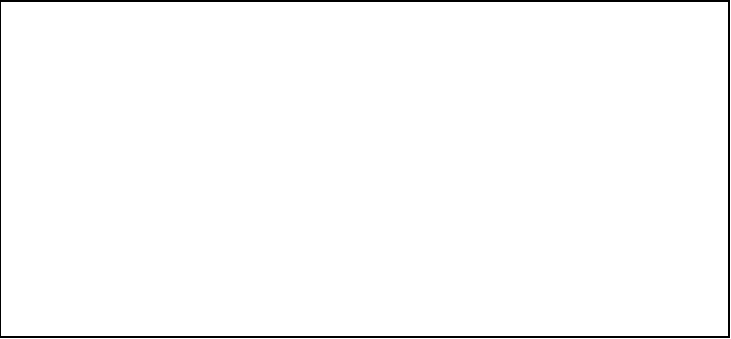
Les épreuves fonctionnelles permettent de donner une appréciation de sévérité des déficits

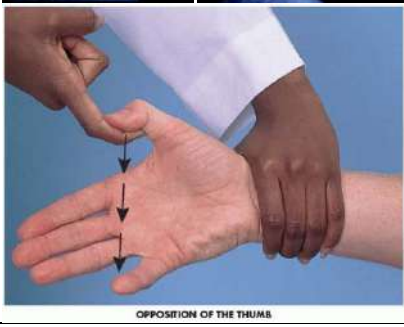
Les troubles à la marche peuvent être revus à la BDFM CHUV, BH (R. Ménétreay, Attention à la marche, Cote WE 103 MEN)

PRATIQUE

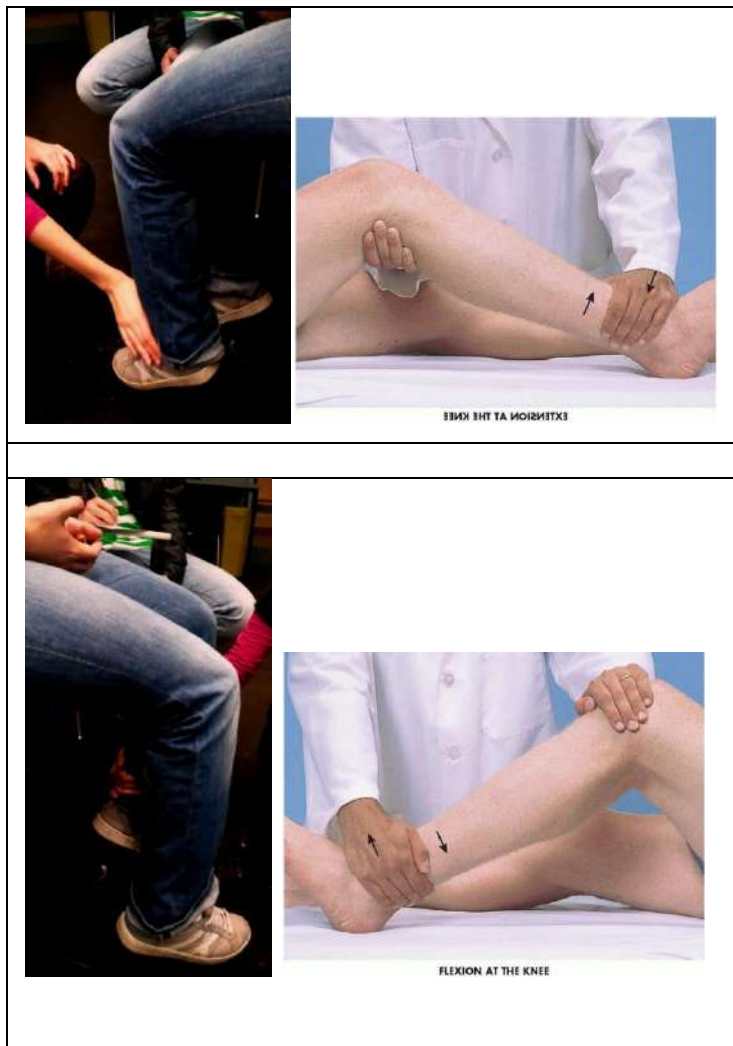
1. Assis, pour l'examen des muscles des membres supérieurs (sous-épineux; deltoïde ; biceps brachial ; triceps brachial ; extenseurs poignet ; fléchisseurs poignets ; extenseurs doigts ; fléchisseurs doigts ; interosseux et abd doigt V ; court abducteur du pouce) et pour les muscles proximaux des membres inférieurs ; fléchisseurs cuisse ; quadriceps ; fléchisseurs genou).
2. Assis ou couché, pour tester la motilité fine des doigts (et des orteils), signe mineur pour une atteinte pyramidale.

Muscles des membres supérieurs	Objectifs	Exemples (assis)
<u>Sous-épineux</u>	Contrer une rotation externe du bras	
<u>Delhoïde</u>	Contrer l'adduction du bras	
<u>Biceps brachial</u>	Patient : flexion de l'avant-bras Examineur : contrer une flexion de l'avant bras	 FLEXION AT ELBOW
<u>Triceps brachial</u>	Patient : Avant-bras en en flexion et effectuer une extension de l'avant-bras Examineur : Contrer une extension de l'avant-bras	 EXTENSION AT ELBOW
<u>Extenseurs poignet</u>	Patient : Faire un poing, mettre en extension le poing et résister à la flexion Examineur : Effectuer une flexion du poignet sur le poing du patient.	

<u>Fléchisseurs poignets</u>	Patient : Flexion de la main le poing fermé et résister à l'extension Examineur : Exercer une force conduisant à l'extension	
<u>Extenseurs doigts</u>	Patient : Main et avant-bras en pronation. Doigts en extension. Examineur : provoque une flexion des doigts en appuyant par-dessus à l'extrémité des doigts	
<u>Fléchisseurs doigts</u>	Patient : bras étendus. Ouvrir la main et serrer les deux doigts de l'examineur aussi fort que possible et ne pas les laisser aller. Examineur : Placer l'index et le majeur sur le creux de la main. Essayer de retirer les doigts en effectuant un mouvement de traction à l'opposée du patient. Tester les deux poignées facilite la comparaison	 

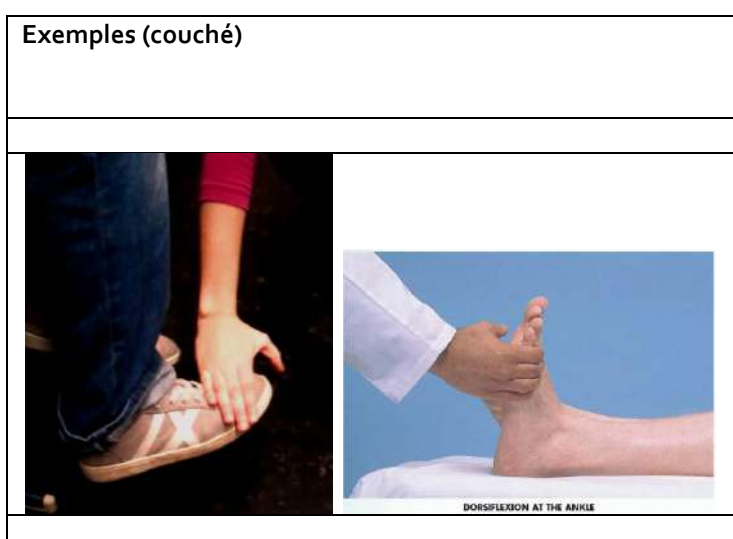
<u>Interosseux et abducteur du 5^e doigt</u>	Patient : Main en pronation. Abduction des doigts de la main. Résister l'adduction. Examineur : Effectuer une adduction des doigts	
<u>Court abducteur du pouce</u>	Patient : Main en supination. Le patient essaie de toucher la pointe du petit doigt (opposition) Examineur : contre le mouvement du pouce (reposition)	  OPPOSITION OF THE THUMB
Muscles proximaux des membres inférieurs	Objectifs	Exemples (assis)
<u>Fléchisseurs de la cuisse</u> <i>Ilio-psoas (L2, L3, L4)</i>	Patient : Flexion de la cuisse (une après l'autre) Examineur : Contrer la flexion <i>Si couché : Le patient soulève sa cuisse et l'examineur oppose une résistance</i>	  FLEXION OF THE HIP

<u>Quadriceps</u> <i>NB : Attention, un des muscles les plus puissants.</i> <i>(L2, L3, L4)</i>	Patient : Extension de la jambe Examineur : contrer l'extension <i>Si couché : L'examineur maintient le genou en flexion. Le patient étend la jambe contre la main.</i>
<u>Fléchisseurs du genou</u> <i>Ischio-jambiers (L4, L5, S1, S2)</i>	Patient : Flexion de la jambe Examineur : Contrer la flexion <i>Si couché : L'examineur place la jambe du patient de manière à que le genou soit fléchi et le pied repose sur le lit. Le patient doit garder le pied contre le lit, lorsque l'examineur essaie d'étendre la jambe.</i>

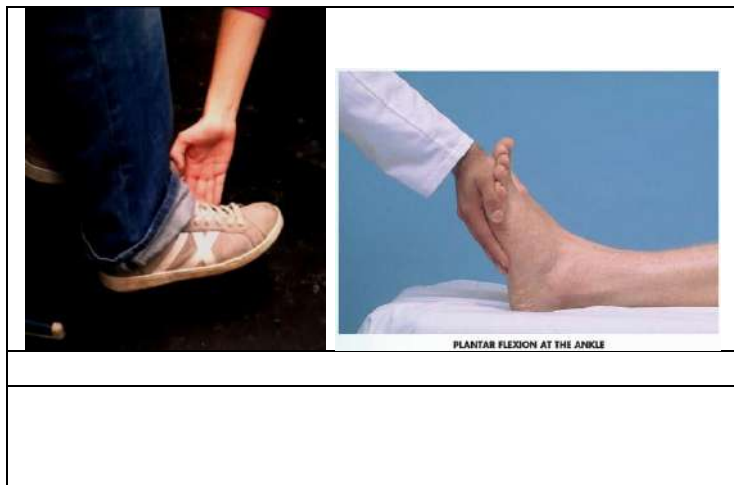


3. Couché, pour l'examen de la partie distale des muscles des membres inférieurs ; extenseurs et fléchisseurs du pied et des orteils ; orteils). Les muscles examinés en position assise peuvent aussi être examinés en position couchée.

Muscles des membres inférieurs	Objectifs
<u>Extenseurs du pied et des orteils</u> <i>Tibial antérieur (L4, L5)</i>	Patient : extension (dorsi-flexion) du pied Examineur : Contrer l'extension

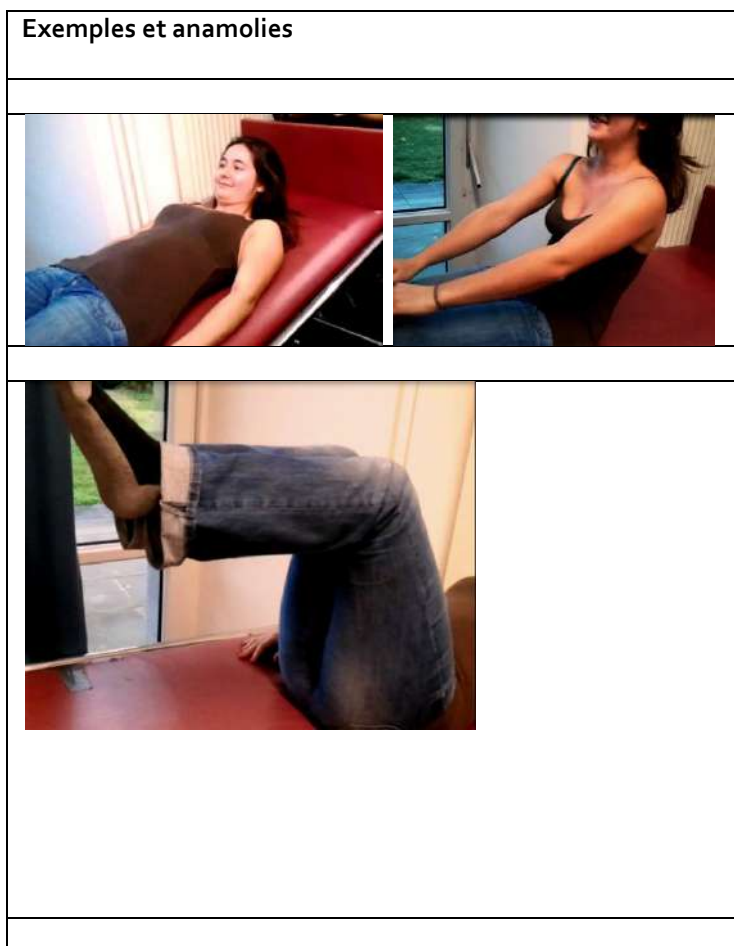


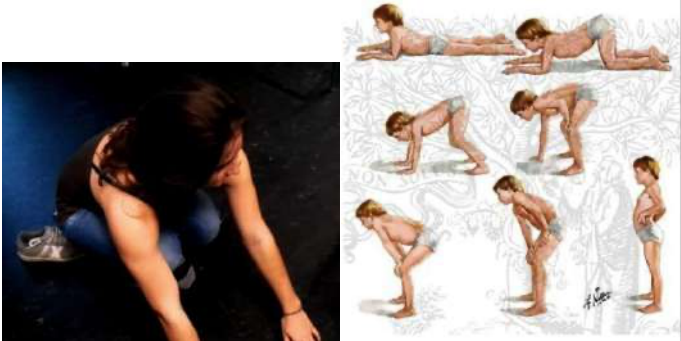
<u>Fléchisseurs du pied et des orteils</u>	Patient : flexion du pied <i>Gastrocnémiens</i> <i>Soléaire</i> <i>(S1)</i>
	Examineur : Contrer la flexion
<u>Orteils</u>	Extension et flexion comme pour les doigts



4. Épreuves fonctionnelles : Relever de la tête et du tronc ; épreuve des bras tendus et jambes fléchies ; élévation des bras en dessus de la tête ; accroupissement et relever possible (si pathologique = signe de Gowers) ou épreuve du tabouret ; marche sur les pieds et les talons ; tient sur une jambe (si parésie du moyen fessier = signe de Trendelenbourg).

Epreuves fonctionnelles	Objectifs & Constatations
<u>Relever le tête et le tronc</u>	
<u>Jambes fléchies</u>	Les manœuvres de Mingazzini (sur le dos) ou de Barré (sur le ventre) explorent la force des muscles fléchisseurs de cuisse. Le patient doit garder les cuisses fléchies à 90° sur le bassin pendant quelques secondes; une chute du côté atteint peut alors survenir.



<u>Bras tendus</u>	20 à 30 secondes avec les deux bras tendus vers l'avant, en supination, et les yeux fermés. <i>En demandant au patient de garder les bras et les yeux fermés, l'examineur appuie sur les bras brusquement vers le bas. Les bras normalement retournent en douceur vers leur position horizontale. Son absence indique une faiblesse, un manque de coordination.</i>	 <i>Flexion et pronation au niveau du coude et dérive vers le bas en cas la lésion du faisceau pyramidal contre-latéral.</i>
<u>Elévation des bras au-dessus de la tête</u>		
<u>Accroupissement et se relever</u>	Signe de Gowers : Parésie de la musculature proximale des membres inférieurs. Le patient est obligé de se servir de ses mains et de ses bras pour passer de la position agenouillée à la position debout (manque de force des muscles des hanches et des cuisses).	
<u>Épreuve du tabouret</u>	<i>Se relever à partir de la position assise,</i>	<i>Une difficulté à cette à cette épreuve suggère une faiblesse des muscles proximaux (extenseurs de la hanche, du quadriceps</i>

	<i>sans s'aider des bras, et monter sur un tabouret solide sont des tests plus adéquats que les sautilllements et les g�nuflexions quand les patients sont �g�s ou faibles.</i>	<i>(extenseur du genou), ou des deux. Les gens qui ont une diminution de la force des muscles de la ceinture pelvienne et des membres inf�rieurs ont du mal � faire ces exercices.</i>
<u>Marcher sur les pieds et les talons</u>	<i>Marcher, la pointe d'un pied touchant le talon de l'autre, en ligne droite.</i> <i>Marcher sur la pointe des pieds, puis sur les talons: des tests sensibles, respectivement, de la flexion plantaire et dorsale des chevilles, aussi bien que de l'�quilibre.</i>	<i>Marcher dans la pi�ce ou aller jusqu'au couloir, faire demi-tour et revenir. Observez son attitude, son �quilibre, le balancement des bras et les mouvements des membres inf�rieurs. Normalement, l'�quilibre est ais�, les bras se balancent sur les c�t�s et les demi-tours sont accomplis sans �-coups. Une d�marche incoordonn�e, chancelante, instable est dite ataxique. L'ataxie peut �tre due � une pathologie c�r�belleuse, la perte du sens de la position ou une intoxication.</i> <i>la d�marche point du pied-talon peut r�v�ler une ataxie non �vidente jusque-l�.</i> <i>La marche sur la pointe des pieds ou les talons peut r�v�ler une faiblesse musculaire distale des membres inf�rieurs. L'impossibilit� de marcher sur les talons est un test sensible de l�sion du faisceau corticospinal.</i>
<u>Tenir sur une jambe</u>	Le signe de Trendelenbourg correspond � une par�sie du moyen fessier (image de droite)	

RÉFLEXES

THÉORIE

- Rappel de la cotation 0 - 4+ (normal 2+ ; si >2+ = sémiologie pyramidale ; si <2+ = sémiologie périphérique) :

Méthode habituelle pour décrire les ROT et les réflexes cutanés plantaires

☐ Droitier ☐ Gaucher

Réflexes	D ^r	G ^a	de 0 (absent) à ++++ (vif et clonique), normal = ++
Stylo-radial (brachioradial)	2+	2+	
Biceps brachial	2+	2+	
Triceps brachial	2+	2+	
Fléchisseurs des doigts			
Cutanés abdominaux supérieurs	+	+	
Cutanés abdominaux inférieurs	+	+	
Rotulien (quadriceps)	2+	2+	
Achilléen (triceps sural)	2+	2+	
Réflexe cutané plantaire recherche du signe de Babinski)	↓	↓	

In English, pretty the same, as follows:

	Right	Left
Biceps	2+	2+
Triceps	2+	2+
Brachioradialis	2+	2+
Patellar	2+	2+
Achilles	2+	2+
Plantar	↓	↓

*Grades 0 to 4+ (see text) used for all but plantar reflex, which is down (↓, normal), absent (0), or up (↑, abnormal). Other reflexes must be added and charted as needed.

- L'étude des niveaux métamériques sont limités lors de l'étude des ROT:
 - Seuls sont examinés C6 et C7 aux membres supérieurs.
 - L4 et S1 aux membres inférieurs.
- Utiliser un marteau à tête lourde.
- Lors du déclenchement des ROT, évoquer 2-3 fois à 1 niveau, puis déclencher le même ROT controlatéral.
- Utiliser les manœuvres de facilitation connues (pour créer une inhibition physiologique)

Si les réflexes du patient sont diminués ou abolis de façon symétrique, on utilise le renforcement, une technique faisant appel à la contraction isométrique d'autres muscles (pendant au plus 10 secondes), qui peut accroître l'activité réflexe.

Pour les réflexes des membres supérieurs, demandez par exemple au sujet de serrer les dents ou de comprimer sa cuisse avec sa main opposée.

Si les réflexes des membres inférieurs sont diminués ou abolis, vous pouvez les renforcer en demandant au sujet de tenter d'écarter l'une de l'autre les deux mains réunies par les doigts en crochets (manœuvre de Jendrassik). Dites bien au patient de tirer juste avant de percuter le tendon.

Il peut aussi décoller la tête du plan du lit (ou fermer sa mâchoire) ou effectuer une flexion plantaire (c).¹

¹ D'après Barbara Bates

PRATIQUE

Encourager le patient à se détendre. Utiliser les manœuvres de facilitation.

Les réflexes s'effectuent des deux côtés. Le réflexe contre-latéral suit le premier réflexe de manière à pouvoir les comparer.

Tous les ROT sont évocables du même côté du lit sauf 1 Achilléen controlatéral.

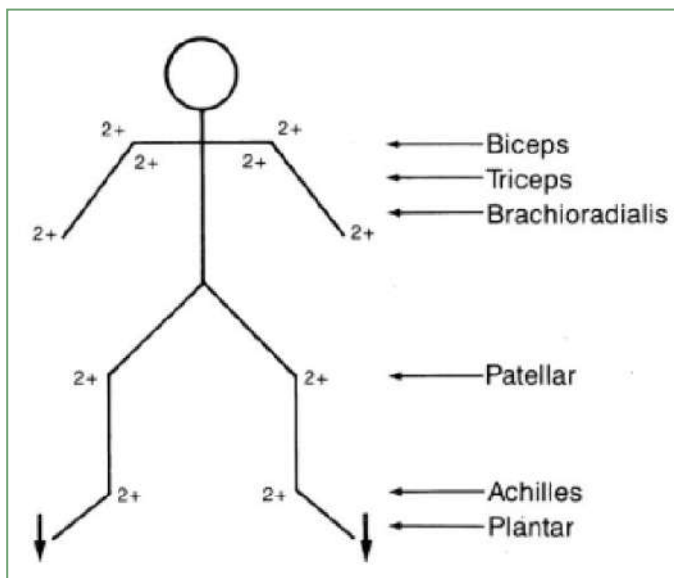
Tenez le marteau à réflexe de manière lâche, entre le pouce et l'index afin qu'il pivote librement dans un arc (limité par la paume de la main et des doigts autres). Avec le poignet détendu, frapper le tendon vivement à l'aide d'un mouvement du poignet rapide.

Notez la vitesse, la force et l'amplitude de la réponse réflexe et la qualité de la réponse en utilisant l'échelle. N'oubliez pas de toujours comparer la réponse d'un côté à l'autre.

Erreurs fréquentes:

- ⚠ Le marteau n'atteint pas la cible du tendon.
- ⚠ Le marteau n'est pas déclenché assez fort.
- ⚠ Les ROT ne sont pas évoqués du même côté du lit.
- ⚠ Le réflexe cutané plantaire n'est pas frotté suffisamment au bord latéral du pied jusqu'à la base du gros orteil.

Utiliser le schéma suivant pour la prise de notes :

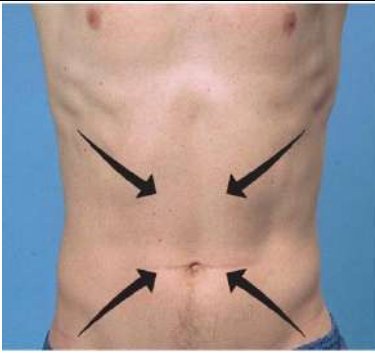
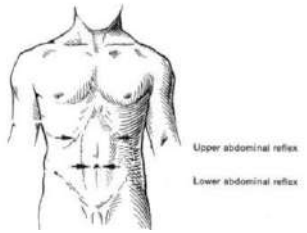


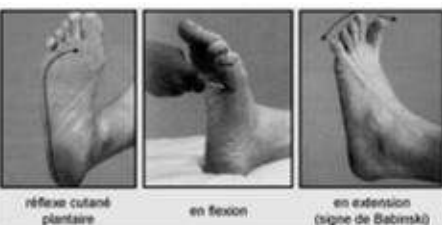
Muscles	Comment faire?	Patient assis	Patient couché	Si problèmes
<u>Biceps brachial</u> ROT bicipital (C5-C6)	• Avant-bras tenu flechi • Percussion du pouce de l'examineur placé sur le tendon d'insertion du biceps • Contraction du biceps et flexion de l'avant bras sur le bras	 PATIENT SITTING	 PATIENT LYING DOWN	
<u>Triceps brachial</u> ROT tricipital C7)	• Avant-bras tenu fléchi • Epaule légèrement surélevée • Percussion du tendon du triceps au-dessus de l'olécrâne. • Contraction du triceps brachial et extension de l'avant bras.			 Si le patient n'arrive pas à se détendre, essayez de soutenir le bras. Demander au patient de se laisser aller (bras mous).

<u>Brachio-radial</u> ROT brachioradial (C6)	• Avant-bras tenu en demi-flexion et demi-supination • Percussion de l'apophyse styloïde du radius • Contraction du long supinateur et flexion de l'avant-bras			
<u>Quadriceps</u> ROT rotulien ou quadricipital (L4)	• Membre inférieur en légère flexion et soutenu au niveau du creux poplité par l'examineur pour bien détendre la cuisse ou position assise • Percussion du tendon d'insertion du quadriceps sous la rotule • Contraction du quadriceps et extension de la jambe	 PATIENT SITTING		 Deux méthodes sont utiles lorsque l'on examine le patient en décubitus dorsal. Soutenir les deux genoux à la fois, comme indiqué ci-dessous à gauche, vous permet d'évaluer de petites différences entre les réflexes du genou (tester de manière répétée un réflexe, puis l'autre). Parfois, cependant, soutenir deux jambes rend mal à l'aise à la fois l'examineur et le patient. Vous pouvez reposer votre bras de support sous la jambe du patient, comme illustré ci-dessous à droite. Certains patients trouvent plus facile de se détendre avec cette méthode.

Achillien ROT Achillien (S1)	- Le genou fléchi du patient repose en abduction sur le lit. - L'examineur tient le pied en position intermédiaire et percute le tendon d'Achille. - Contraction du triceps sural et extension du pied	 PATIENT SITTING	 PATIENT LYING DOWN	
---	--	---	---	---

Réflexes cutanés :
A réaliser uniquement en position couchée !

Cutané abdominal	- Gratter légèrement mais rapidement chaque côté de l'abdomen, au dessus (T8, T9, T10) et au-dessous (T10, T11, T12) de l'ombilic, selon les directions indiquées dans la figure. - Servez-vous d'une clef, d'un écouvillon ou d'un abaisse-langue fendu longitudinalement. - Notez la contraction des muscles abdominaux et la déviation de l'ombilic vers le stimulus.	 Réflexes cutanés abdominaux (absents dans les atteintes pyramidales!)  Upper abdominal reflex Lower abdominal reflex	L'obésité peut masquer un réflexe abdominal. Dans ce cas, utilisez un doigt pour tirer l'ombilic du sujet du côté opposé à la stimulation. On perçoit la contraction musculaire avec le doigt qui rétracte l'ombilic.
-------------------------	--	--	--

Réflexe cutané plantaire (=RCP) (L5, S1).	- Appliqué un objet depuis la face latérale de la semelle du talon à la pointe du pied - Utilisez un léger stimulus et appuyer plus fortement si nécessaire. - Mouvement du gros orteil, flexion plantaire	  réflexe cutané plantaire en flexion en extension (signe de Babinski)	 Si extension anormale des orteils = signe de Babinski
--	--	--	--

SENSIBILITÉ

THÉORIE

Rappel des différentes modalités protopathiques et épicritiques

Connaître les niveaux métamériques : mamelons, ombilic, racines des extrémités

La précision de l'examen est fonction du contexte

Les épreuves fonctionnelles permettent de donner une appréciation de sévérité des déficits

PRATIQUE

L'examen débute au niveau de la base unguéale des indes et des gros orteils. Si la personne n'a pas de sensibilité/reconnaissance, il faut remonter proximale vers le poignet/cheville et le coude/genoux.

En effet, une cartographie sensorielle méticuleuse permet d'établir le niveau d'une lésion de la moelle épinière et de déterminer si cette lésion résulte d'une lésion d'une racine nerveuse, un nerf périphérique principale, ou l'une de ses branches.

Il faut toujours comparer des zones symétriques sur les deux côtés du corps, y compris les bras, les jambes et le tronc.

RECONNAISSANCE AU PIQUER – TOUCHER

Lorsqu'on teste la douleur, la température et la sensation du toucher, on compare les deux zones symétriques du corps et les régions distales avec les régions proximales.

Les dermatomes testés sont :

- Les deux épaules (C4),
- Les régions interne et externe de l'avant-bras (C6 et T1),
- Les pouces et les petits doigts (C6 et C8)
- Le devant des deux cuisses (L2)
- Les aspects médians et latéraux de deux veaux (L4 et L5)
- Les petits orteils (S1)
- La face interne de chaque fesse (S3).

On utilise un coton-tige pour le test de la douleur et celui du toucher. **Les stimulations toucher/piquer doivent être légères et répétées au même site, 2-3 fois.**

Toucher :

- Appliquez le coton sur les différents dermatomes.
- Touchez légèrement la peau, en évitant la pression.
- Demandez au patient de faire signe chaque fois qu'un touché est ressenti.
- Comparez d'un côté du corps à un autre.
- Normalement, la peau est normalement relativement insensible et devrait être évitée.

Douleur :

- Même procédure mais avec les pics du coton-tige cassé en deux.
- Demander au patient si la douleur est aiguë ou sourde ou de comparer («Est- ce que vous ressentez la même chose ? »).

Température :

- Le sens de température nécessite l'utilisation de petits Erlenmeyer remplis d'eau chaude/froide.
- Le patient indique si la sensation est froide ou chaleureuse.

RECONNAISSANCE DU SENS DE POSITION (OU ARTHOCINÉSIE)

Lors du test de vibration et du sens de position, il faut d'abord tester les doigts et les orteils. Si ceux-ci sont normaux, vous pouvez supposer que les zones plus proximales sont également normales.

L'examineur saisit le gros orteil/pouce de manière latérale. Il exécute ensuite des mouvements rapides. Le patient doit indiquer, les yeux fermés, la position du pouce ou de l'orteil.

RECONNAISSANCE DU SENS VIBRATOIRE (OU PALLESTHÉSIE)

Un diapason de 128 ou 256Hz est utilisé et est appliqué sur une saillie osseuse.

L'examineur fait vibrer le diapason. Le patient lui indique lorsqu'il ne ressent plus rien. L'examineur à ce moment-là, observe la cotation.

Normalement, on place le diapason sur le bord antérieur du tibia, les chevilles et les processus styloïdes.

STÉRÉOGENÈSE (MODALITÉS COMPLEXES)

La stéréognosie, aussi appelée gnose tactile se définit par la capacité d'une personne à reconnaître et identifier les caractéristiques d'un objet ou d'une forme géométrique uniquement en sollicitant les perceptions tactiles (toucher, texture et température) et les informations proprioceptives (pression, position, mouvement et poids) que l'objet ou la forme fournissent (Carlson & Brooks, 2009).

On utilise une pièce de monnaie ou un objet et on demande au patient d'indiquer le type de monnaie (20 centimes ou 1 franc). L'autre possibilité est de dessiner le chiffre 3 sur la peau

Nota bene : L'étude du sens de la stéréognosie (objet fin dans la main sans contrôle visuel) peut être utile dans une appréciation intégrée des sensibilités (cortex pariétal).

ÉPREUVES FONCTIONNELLES

DÉMARCHE DU FUNAMBULE (PIEDS APPONDUS L'UN DEVANT L'AUTRE)

ÉPREUVE DE ROMBERG, D'ABORD PIED SERRÉS ET BRAS TENDUS, PUIS FERMETURE OCULAIRE

ÉPREUVE DES BRAS TENDUS ET JAMBES FLÉCHIES.

Erreurs fréquentes : ; les sites d'examen sont fonction des hypothèses de travail : déséquilibre à la marche (cidessus), dans un territoire d'innervation d'un tronc nerveux ou d'une main ; dans les troubles sphinctériens, ne pas oublier de rechercher des déficits au niveau de la queue de cheval (faces postérieures des cuisses et des jambes, fesses et périnée).

Lorsque vous détectez des résultats anormaux, les mettre en corrélation avec le moteur et l'activité réflexe.

Évaluer le patient attentivement, car vous poser les questions suivantes: Est de la lésion sous-jacente centrale

ou périphérique?

Est la perte sensorielle unilatérale ou bilatérale? A-t-il un modèle suggérant une distribution métamérique, une poly-neuropathie, ou un syndrome de la moelle épinière avec une perte de la douleur et de la sensation de température mais aussi le toucher intact et les vibrations?

Comparer zones symétriques sur les deux côtés du corps, y compris les bras, les jambes et le tronc.

Lorsque vous détectez une zone de perte

sensorielle ou d'hypersensibilité, tracer ses frontières en détail. Stimuler première en un point de la sensibilité réduite, et se déplacer par étapes progressives jusqu'à ce que le patient détecte le changement.

